2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

# PLANILHA SEMI-AUTOMATIZADA PARA VIGILÂNCIA DE HIPERTENSÃO E DIABETES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Ana Aline Rodrigues Oliveira - Enfermeira Residente no Programa Multiprofissional em Saúde da Família - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP
Josefa Yolanda Vitório Costa - Enfermeira Residente no Programa Multiprofissional em Saúde da Família - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP
Jeorgia Costa Lima - Enfermeira e preceptora da Estratégia de Saúde da Família em Recife/PE
Shirlene Alves Alheiros - Enfermeira e preceptora da Estratégia de Saúde da Família em Recife/PE

## Modelo de preenchimento de planilha semi-automatizada de acompanhamento da Pessoa com Diabetes e/ou Hipertensão

- Ter pelo menos 01 consulta presencial ou remota realizadas por enfermeira e/ou médico, nos últimos 06 meses (DM / HAS);
- Ter pelo menos 01 registro de aferição de pressão arterial realizado nos últimos 06 meses (DM / HAS);
- Ter pelo menos 01 registro simultâneos de peso e altura realizado nos últimos 12 meses (DM / HAS);
- Ter pelo menos 02 visitas domiciliares realizadas por ACS, com intervalo mínimo de 30 dias, nos últimos 12 meses (DM / HAS);
- Ter pelo menos 01 registro de solicitação de hemoglobina glicada realizada ou avaliada, nos últimos 12 (doze) meses (DM);
- Ter pelo menos 01 avaliação dos pés realizada nos últimos 12 meses (DM).

| NOME | CPF | DN | ACS | COMORBIDADES | TABAGISMO | CARGA TABÁGICA | RISCO CARDIOVASCULAR | CONSULTA ENFA E/OU MED | REGISTRO DE PA | IMC | HbA1c | AVALIAÇÃO DOS PÉS | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | HAS | NEGA | | BAIXO | < 6 MESES | NORMAL | BAIXO PESO | AVALIADA | REALIZADA | |
| | | | | HAS + DM2 | ATIVO | | INTERMEDIÁRIO | > 6 MESES | ALTERADA | EUTROFICO | NORMAL | PENDENTE | |
| | | | | HAS + DMID | CESSOU | | ALTO | | | SOBREPESO | SOLICITADA | | |
| | | | | HAS + DISLIPIDEMIA | | | MUITO ALTO | | | OBESIDADE GRAU I | ALTERADA | | |
| | | | | HAS + DM2 + DISLIPIDEMIA | | | | | | OBESIDADE GRAU II | PENDENTE | | |
| | | | | HAS + DMID + DISLIPIDEMIA | | | | | | OBESIDADE GRAU III | | | |
| | | | | DM2 | | | | | | | | | |
| | | | | DMID | | | | | | | | | |
| | | | | DM2 + DISLIPIDEMIA | | | | | | | | | |
| | | | | DMID + DISLIPIDEMIA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Fonte: Acervo pessoal, 2026.

## PRINCIPAIS ACHADOS

- A planilha semi-automatizada configura-se como uma tecnologia leve-dura, de baixo custo e com preenchimento prático, facilitando o uso pelos profissionais.
- A ferramenta contribui para a organização das informações, identificação de lacunas no cuidado e planejamento das ações.
- Os indicadores de acompanhamento adotados baseiam-se na Nota Técnica nº 30/2025, referente ao cofinanciamento federal do Piso da Atenção Primária à Saúde no SUS.

## Introdução

A Atenção Primária à Saúde exerce papel central na coordenação do cuidado e na vigilância em saúde, especialmente no acompanhamento de condições crônicas como hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM). Fragilidades no processo de trabalho das equipes podem comprometer o monitoramento longitudinal desses usuários, dificultando a busca ativa e o rastreamento oportuno.

## Objetivo

Relatar a experiência de desenvolvimento e implementação de uma planilha para monitoramento de usuários com HAS e DM em uma Unidade de Saúde da Família (USF).

## Método

- **Tipo de estudo:** descritivo, do tipo relato de experiência, com abordagem qualitativa.

↓

- **Local do estudo:** Uma Unidade de Saúde da Família do DS I em Recife/PE.

↓

A intervenção iniciou-se em fevereiro de 2026, a partir da identificação da ausência de ferramentas centralizadas para acompanhamento territorial.

## Resultados

Como resposta, foi construída uma planilha semi-automatizada na plataforma Google Planilhas, destinada à organização de dados clínicos e administrativos, identificação de faltosos e apoio às ações de busca ativa. A ferramenta foi apresentada em reuniões e acompanhada de capacitação para os profissionais, respeitando os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

## Conclusão

A experiência demonstra que ferramentas digitais simples e de baixo custo podem fortalecer a vigilância em saúde e qualificar o processo de trabalho na APS.

**INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP**
ANA ALINE RODRIGUES OLIVEIRA
ENFERMEIRA RESIDENTE NO PROGRAMA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA

E-mail: analiinerodrigues@gmail.com
Contatos: (82) 98728-5491

IMIP